



Resifriends  
*By Fátima Barbosa*

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO

# Imunização e PNI

---

Calendário vigente · Rede de frio · Contraindicações — teoria e  
bizus

Concurso de Enfermagem / Pernambuco · Cargo: Enfermeiro

PESO ALTO · PONTO QUASE GARANTIDO

Profa. Fátima Barbosa

Calendário conferido · PNI / Ministério da Saúde (2026)

# Por que imunização é ponto certo

*Imunização cai em quase toda prova de enfermagem — e é território do enfermeiro na sala de vacina. Quem domina o calendário, a rede de frio e as contraindicações garante essas questões.*

Este ebook cobre o **Calendário Nacional de Vacinação** (Programa Nacional de Imunizações — PNI), a **rede de frio**, as **vias de administração** e as **contraindicações** — com atenção às falsas contraindicações, que são a pegadinha preferida da banca.

## O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Calendário do PNI 2026** — criança, adolescente e gestante.
- ◆ **Rede de frio** — a temperatura que cai sempre.
- ◆ **Vírus vivo × inativada** — a distinção que define contraindicações.
- ◆ **Falsas contraindicações** — o que NÃO impede vacinar.

## Nota de atualização

O calendário vacinal muda periodicamente. Os dados aqui foram conferidos nas fontes oficiais (PNI e Ministério da Saúde) na versão vigente. **Sempre confirme o calendário do ano no site do Ministério da Saúde antes da prova** — é o dado que mais se atualiza.

# Sumário

---

## 1 O calendário do primeiro ano

Ao nascer

2, 4 e 6 meses

Reforços

## 2 Tipos de vacina e vias

Vírus vivo × inativada

Vias e locais

## 3 Contraindicações

Verdadeiras

Falsas — a pegadinha

## 4 Rede de frio

Temperatura

Conservação e falhas

## 5 Síntese e bizzus finais

Quadro de revisão rápida

# 1

## O calendário

---

O primeiro ano de vida concentra o maior número de doses — e de questões.

# 1 · As vacinas do primeiro ano

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, é referência mundial. O primeiro ano de vida concentra a maior parte do esquema básico. Veja a estrutura vigente:

Calendário Nacional de Vacinação — Criança · PNI / Ministério da Saúde, 2026

| IDADE        | VACINAS                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ao nascer    | <b>BCG</b> (dose única, intradérmica) e <b>Hepatite B</b> (1 dose).                                                 |
| 2 meses      | <b>Penta</b> (1ª), <b>VIP</b> (1ª), <b>Pneumo 10</b> (1ª), <b>Rotavírus</b> (1ª).                                   |
| 3 meses      | <b>Meningocócica C</b> (1ª).                                                                                        |
| 4 meses      | <b>Penta</b> (2ª), <b>VIP</b> (2ª), <b>Pneumo 10</b> (2ª), <b>Rotavírus</b> (2ª).                                   |
| 5 meses      | <b>Meningocócica C</b> (2ª).                                                                                        |
| 6 meses      | <b>Penta</b> (3ª), <b>VIP</b> (3ª), <b>Influenza</b> , <b>Covid-19</b> .                                            |
| 9 meses      | <b>Febre amarela</b> (1ª).                                                                                          |
| 12 meses     | <b>Pneumo 10</b> (reforço), <b>Meningocócica ACWY</b> , <b>Tríplice viral</b> (1ª).                                 |
| 15 meses     | <b>DTP</b> (1º reforço), <b>VIP</b> (1º reforço), <b>Tríplice viral</b> (2ª), <b>Varicela</b> , <b>Hepatite A</b> . |
| 4 anos       | <b>DTP</b> (2º reforço), <b>Febre amarela</b> (reforço), <b>Varicela</b> .                                          |
| 9 a 14 anos  | <b>HPV4</b> — dose única.                                                                                           |
| 10 a 14 anos | <b>Dengue</b> (2 doses).                                                                                            |
| 11 a 14 anos | <b>Meningocócica ACWY</b> (1 dose).                                                                                 |

### APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O que mudou — e o material antigo ainda ensina errado. Confira contra a sua apostila:

- Aos **12 meses**: entra a **meningocócica ACWY** (protege contra A, C, W e Y), no lugar do antigo reforço de *meningo C*. Há também dose de ACWY dos **11 aos 14 anos**.
- **HPV**: hoje é **dose única**, de **9 a 14 anos** — antes eram 2 doses.
- **Dengue** entrou no calendário: **10 a 14 anos**, 2 doses.
- Aos **15 meses e 4 anos**: o reforço da pólio hoje é com **VIP** (inativada) — a **VOP** (gotinha) **saiu** do calendário de rotina.
- Aos **15 meses**: **varicela monovalente** (a tetraviral só é usada se houver indisponibilidade).
- **Covid-19** integra o calendário infantil (a partir dos 6 meses).
- **Influenza** hoje é **trivalente** (não quadrivalente).
- A **pentavalente** substituiu a tetravalente — se sua apostila diz “tetra aos 2-4-6 meses”, ela está velha.

### PEGADINHA CLÁSSICA

Se o seu material de estudo traz **meningo C** aos 12 meses, **HPV** em 2 doses, **VOP** aos 15 meses ou **tetravalente**, ele está **desatualizado**. O calendário é revisado **todo ano** — este é o erro que mais deruba quem estuda por apostila antiga.

### BIZU ESTRATÉGICO

O trio **2-4-6 meses** é o mais cobrado: Pentavalente, VIP, Pneumo 10 (e Rotavírus só na 1ª e 2ª). Guardar esse bloco resolve muitas questões de “qual vacina aos X meses”.

## 1 · O calendário da gestante

A vacinação da gestante protege **duas pessoas** — e sofreu atualização recente. As vacinas de rotina na gravidez:

Calendário Nacional de Vacinação — Gestante · Ministério da Saúde, 2026

| VACINA                           | ESQUEMA                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dTpa                             | 1 dose a partir da 20ª semana, em cada gestação.                                                   |
| Influenza                        | 1 dose por temporada, em qualquer idade gestacional.                                               |
| Hepatite B                       | 3 doses, conforme histórico vacinal.                                                               |
| dT                               | 3 doses, conforme histórico vacinal.                                                               |
| Covid-19                         | 1 dose a cada gestação.                                                                            |
| VSR (Vírus Sincial Respiratório) | <b>NOVIDADE.</b> 1 dose em cada gestação. Protege o recém-nascido contra bronquiolite e pneumonia. |
| Febre amarela                    | Apenas em caso excepcional (área de risco), após avaliação — é vírus vivo.                         |

#### APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica da vacinação na gestação: os anticorpos maternos **atravessam a placenta** e dão **imunidade passiva** ao bebê nos primeiros meses — justamente a janela em que ele ainda não pode receber as próprias vacinas. É por isso que a **dTpa é repetida em toda gestação**, mesmo que a mulher já a tenha tomado: o objetivo não é (só) protegê-la, é *transferir anticorpo fresco* para aquele bebê.

#### PEGADINHA CLÁSSICA

**Divergência de fontes sobre a VSR.** A página do Calendário Nacional traz “a partir da 28ª semana”; a Caderneta da Gestante e materiais de capacitação trazem “entre 32 e 36 semanas”. É vacina de incorporação recente, com recomendação em ajuste. **Confirme a janela na versão vigente** — e, se o enunciado citar a fonte, siga a fonte citada.

# 2

## Tipos e vias

---

Saber se a vacina é de vírus vivo define quem pode e quem não pode recebê-la.



## 2 · Vírus vivo, inativada e vias

A distinção mais importante para a prova é entre vacinas de **agente vivo atenuado** e **inativadas**, porque ela governa as contraindicações.

| TIPO                       | EXEMPLOS                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vírus/agente vivo atenuado | BCG, Rotavírus, Febre amarela, Tríplice viral, Varicela, Tetra viral. (A VOP era vírus vivo, mas saiu do calendário de rotina — hoje a pólio é só VIP, inativada.) |
| Inativadas / componentes   | Hepatite B, Pentavalente, VIP, Pneumocócica, Meningocócica, Hepatite A, DTP, Influenza.                                                                            |

### BIZU ESTRATÉGICO

Mnemônico para vírus vivo: “**Beber Febre Também Vale**” — BCG, Febre amarela, Tríplice/Tetra viral, Varicela/Rotavírus. São essas que exigem cautela em gestante e imunossuprimido.

### ◆ Vias e locais de administração

| VACINA                         | VIA / LOCAL                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BCG                            | Intradérmica (ID), no braço direito (inserção do deltoide).     |
| Hepatite B / Pentavalente      | Intramuscular (IM), vasto lateral da coxa no lactente.          |
| Rotavírus                      | Oral. Se a criança regurgitar ou vomitar, não se repete a dose. |
| Rotavírus                      | Oral.                                                           |
| Tríplice viral / Febre amarela | Subcutânea (SC).                                                |

### PEGADINHA CLÁSSICA

A BCG é **intradérmica** — nunca IM ou SC. E se a criança regurgitar ou vomitar após a vacina **oral** (rotavírus), **não se repete a dose**. A banca adora a “redose” que não existe.

# 3

## Contraindicações

---

A pegadinha de ouro da imunização: o que parece impedir a vacina, mas não impede.

### 3 · Verdadeiras e falsas

#### ◆ Contraindicações verdadeiras

- ◆ Reação anafilática grave a dose anterior ou a componente da vacina.
- ◆ Vacinas de **vírus vivo** em **gestantes** e em **imunossuprimidos graves** (avaliar caso a caso).
- ◆ Para a BCG: recém-nascido com peso inferior a 2 kg (adiar).

#### ◆ Falsas contraindicações — não impedem vacinar

##### CAI EM PROVA

- ◆ Doença aguda **leve** com febre baixa (resfriado comum).
- ◆ Uso de **antibiótico**.
- ◆ Desnutrição.
- ◆ História familiar de evento adverso.
- ◆ Prematuridade (respeitando a idade cronológica).
- ◆ Aleitamento materno.
- ◆ Alergias que não sejam anafiláticas ao componente.

##### PEGADINHA CLÁSSICA

Esta é a pegadinha número um do eixo: a banca lista uma **falsa contraindicação** (febre baixa, uso de antibiótico, desnutrição) como se impedisse a vacinação. Não impede. Só anafilaxia e, para vírus vivo, gestação/imunossupressão grave são barreiras reais.

# 4

## Rede de frio

---

A temperatura que cai em toda prova de imunização: +2°C a +8°C.

## 4 · Conservação dos imunobiológicos

A rede de frio (ou cadeia de frio) é o sistema que garante a conservação dos imunobiológicos, da fabricação à aplicação. Na sala de vacina — instância local — a regra de ouro é a temperatura.

Manual de Rede de Frio · PNI / Ministério da Saúde

### NÚMEROS QUE CAEM

- ◆ Temperatura na sala de vacina: **+2°C a +8°C** (ideal em torno de +5°C).
- ◆ Leitura e registro da temperatura: **no mínimo 2 vezes ao dia** (início e fim do expediente).
- ◆ Termômetro de máxima e mínima na prateleira central.
- ◆ Proibido usar geladeira doméstica comum ou frigobar para armazenar vacinas.

#### PEGADINHA CLÁSSICA

A faixa **+2°C a +8°C** é a resposta padrão. Alternativas com “0°C”, “abaixo de zero” ou “-20°C” para a *sala de vacina* estão erradas — o congelamento **inutiliza** vacinas, especialmente as inativadas/adsorvidas. O congelamento é a falha mais comum e mais grave da cadeia de frio.

Em caso de **falta de energia** ou temperatura fora da faixa: manter a porta fechada, acionar a normalização, comunicar a instância responsável e, se houve exposição, **segregar e identificar** os imunobiológicos até avaliação — nunca descartar ou usar por conta própria.

5

## Síntese

---

A página que blinda o eixo de imunização.

## 5 · Revisão rápida do eixo

### CALENDÁRIO 2026 E VIAS

- ◆ Ao nascer: **BCG** (ID) e **Hepatite B**.
- ◆ Bloco 2-4-6 meses: **Penta + VIP** nos três; Pneumo 10 e Rotavírus só aos 2 e 4. Meningo C aos **3 e 5**.
- ◆ **12 meses: meningo ACWY** (não mais meningo C). **HPV: dose única (9-14)**. **Dengue: 10-14**.
- ◆ Reforço da pólio aos 15 meses e 4 anos é com **VIP** — a VOP saiu da rotina.
- ◆ Gestante: **dTpa a partir da 20ª semana em cada gestação** + influenza + covid + **VSR**.
- ◆ BCG é **intradérmica**; vacina oral regurgitada não se repete.
- ◆ Vírus vivo: BCG, febre amarela, tríplice/tetra viral, varicela, rotavírus.

### CONTRAINDICAÇÕES E REDE DE FRIO

- ◆ Verdadeiras: anafilaxia; vírus vivo em gestante/imunossuprimido grave.
- ◆ Falsas (não impedem): febre baixa, antibiótico, desnutrição, aleitamento.
- ◆ Sala de vacina: **+2°C a +8°C**; registrar 2×/dia.
- ◆ Congelamento inutiliza vacina; nunca usar frigobar.

#### PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas que mais caem: (1) falsa contraindicação apresentada como impeditiva; (2) temperatura da sala de vacina fora de +2°C a +8°C; (3) repetir dose oral após regurgitação. Domine essas três e você garante o eixo.

*“Na sala de vacina, o enfermeiro protege duas coisas: a criança e a cadeia de frio. A prova cobra as duas.”*

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · IMUNIZAÇÃO

Calendário e normas conferidos nas fontes oficiais: Calendário Nacional de Vacinação 2026 (criança, adolescente e gestante) e manuais do PNI / Ministério da Saúde. O calendário vacinal é atualizado periodicamente — confirme a versão do ano antes da prova.